

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	胃部腫瘤 Gastric Neoplasm				
編號	A31000-Q03-W-K08	制定者	N11 莊淑娟	公布日期	97 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 3.7 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解胃部腫瘤的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

原發於胃部的惡性腫瘤主要有三種，從胃粘膜細胞長出來的叫做「胃腺癌」，從基質細胞長出來的叫做「胃腸道基質細胞瘤」，從淋巴組織長出來的叫做「胃淋巴瘤」。其中以胃腺癌(adenocarcinoma)最為常見，佔了百分之九十以上，所以一般簡稱「胃癌」時，指的都是「胃腺癌」。

（二）症狀

上腹部不適、胃腸脹氣、厭食、食慾不振、惡性飽足感、體重減輕、噁心、嘔吐、咖啡狀嘔吐物、上腸胃道出血、糞便潛血、貧血、主訴疲倦、眩暈、無力、呼吸短促。

（三）常見檢查

1. 胃液分析：會有胃酸缺乏或胃酸過少現象。
2. 上腸胃道攝影(UGI series)：尤以幽門附近腫瘤最易發現。
3. 胃鏡檢查和切片、細胞學檢查(Panendoscopy)。
4. 血液檢查：血紅素及血比容值降低；癌胚抗原(CEA)升高。

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/11

5. 糞便檢查：評估是否有潛血或胃持續出血。

6. 肝臟酵素和胰澱粉酶：用來評估是否侵犯肝臟或胰臟。

(四) 常見治療

1. 外科切除：

(1) 部分胃切除：Billroth I、Billroth II。

(2) 全胃切除術：併行食道空腸吻合術。

2. 化學療法：

5-FU、Adriamycin、Mitomycin C 等。

3. 放射線療法：

減少局部區域性的復發、控制出血或減輕因轉移至骨骼引起的疼痛。

4. 輸血治療：

輸注全血或濃縮紅血球，以矯正貧血。

5. 藥物治療：

(1) Albumin

作用：休克、肝腎症候群血中白蛋白過低。

副作用：低血壓、嘔吐。

(2) Gascon

作用：治療腹脹、鼓腸。

副作用：軟便、胃不適、腹瀉。

(3) Vit K1

作用：治低凝血酶原血症。

副作用：潮紅、過敏。

(4) C-Meta

作用：B 群、C 群缺乏症。

(5) Vit B1

作用：抗神經性維他命、抗腳氣病。

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/11

(6) Primperan

作用：止吐、促消化道運動。

副作用：震顫、便秘、腹痛。

(五) 護理問題

1. 缺乏營養/疾病。
2. 疼痛不適/疾病。
3. 活動耐力不足/疾病。
4. 易感染/化學治療。
5. 易感染/與手術傷口有關。
6. 恐懼/罹患癌症、害怕即將面對死亡。
7. 家庭因應能力：成長潛能/與家庭成員罹患嚴重疾病有關。
8. 尋求(特定的)健康協助（放射線和化學治療的副作用、居家照顧事項）/與資訊不足有關。

(六) 護理措施

1. 缺乏營養/疾病
 - (1)維持舒適的進餐環境。若有嘔吐情形時，需立刻清除嘔吐物，並協助口腔護理，以減輕不適所引起的食慾不振。
 - (2)配合病人食物喜好，建議清淡飲食，避免辛辣、刺激性食物，選擇高蛋白質，如魚、肉、蛋、奶，及高熱量食物，採少量多餐方式進食。若嘔吐厲害，可於飯前依醫囑給於止吐劑。
 - (3)依醫囑由靜脈供給液體和營養物質。每天監測體重的變化，記錄攝入及排出量。
 - (4)依醫囑監測血液白蛋白檢驗值變化。
 - (5)進食前避免執行疼痛措施。
 - (6)採坐姿或半坐姿進食並給予充分時間進食、勿催促，必要時協助進食。
 - (7)衛教營養狀況少於身體需要的症狀，徵象及避免的重要性。

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/11

(8)飲食應採少量多餐，預防發生傾倒徵候群。

2.疼痛不適/疾病

(1)測量生命徵象，觀察其意識型態。

(2)注意安全每班評估疼痛分數性質、部位、持續時間、頻次，並記錄。

(3)藉由語言，冷靜及關懷的態度，以提供病人安全的保證。

(4)當病人疼痛緩解休息時，避免經常干擾病人休息，採集中護理，減少環境的刺激，安排安靜治療環境，必要時限制訪客。

(5)傾聽病人對疼痛的主訴和感受，討論對於疼痛的期望，對病人表同感及無條件的正向尊重。

(6)提供病人定向感。

(7)每 2 小時協助翻身並給予背部按摩，以病人為舒適的臥位促進舒適。情況許可時，協助下床活動。

(8)提供減輕疼痛方法，如:聽音樂、洗澡等鬆弛身體的方法。

(9)依醫囑給予止痛劑，並評估止痛劑的效果。

(10)衛教病人活動時動作輕柔，避免過度拉扯腹部導致疼痛加劇。

3.活動耐力不足/疾病

(1)與病人及家屬共同評估其目前的活動型態，包括：可接受的活動強度、持續時間與次數。

(2)協助病人選擇其喜歡且可融入其生活型態的活動，且每天有一定的活動量。

(3)與病人及家屬討論如何監測病人在活動時的生理及心理反應。

(4)說明活動耐受力之影響因子。

(5)教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使活動無耐力。

(6)鼓勵親友給予病人心理支持，並且在能力範圍內也參與病人的活動與運動計畫。

(7)視需要給予安排飲食諮詢。

(8)依醫囑服用藥物可促進活動的耐力。

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/11

(9)討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求並發展個別化及漸進式的活動。

(10) 協助病人發展實際可行的活動計畫，內容應包括:自我照顧、運動與休閒活動。

(11) 依病人情況採漸進性下床活動，先讓病人坐在床緣→坐在床旁→站立 10 分鐘→走路。當病人姿位改變時，需陪伴在旁，並評估生命徵象是否改變，若發生血壓下降、脈搏速度加快、臉色蒼白等症狀，需立刻讓病人躺回床上。

(12) 每次活動時間不可過長，以 15-30 分鐘為限，每次活動時間最好在進食後半小時進行。

4.易感染/化學治療

(1)衛教病人及家屬個人衛生的重要性，並協助維護病人身體的清潔。

(2)衛教病人當皮膚癢時勿搔抓，以免破皮，可以輕拍皮膚來改善。

(3)協助病人剪短指甲。

(4)須避免使用刺激性沐浴乳、洗髮精、染髮劑、黏性強的膠布與敷料。

(5)建議使用潤滑劑保護皮膚和維持適當的水份。

(6)依醫囑給予抗組織胺和止癢藥物。

(7)建議穿較易吸汗的棉質衣服。

(8)維持衣物床褥的通風及乾淨。

(9)鼓勵攝取均衡飲食，以促使組織修復。

5.易感染/與手術傷口有關

(1)監測生命徵象。

(2)監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。

(3)記錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情況。

(4)觀察傷口敷料外觀。

(5)治療前後洗手。

(6)無菌技術收集標本培養以監測感染存在。

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/11

- (7)依醫囑正確使用冰或熱敷。
 - (8)依醫囑按時給予抗生素。
 - (9)依醫囑以無菌技術換藥。
 - (10)教導保持傷口乾燥及清潔，避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。
 - (11)教導感染的危險因子及預防感染的重要性方法。
 - (12)指導炎症症狀及徵象。
 - (13)教導選擇高蛋白、高維生素飲食，以促進傷口的修復再生。
 - (14)教導避免抽菸及飲酒。
- 6.恐懼/罹患癌症、害怕即將面對死亡
- (1)瞭解病人恐懼程度及對疾病的認知。
 - (2)瞭解病人家庭支持系統是否健全。
 - (3)請主治醫師給予解釋病情可能的變化及目前治療的過程。
 - (4)透過溝通，增加家庭的支持系統，讓病人獲得關懷、增加安全感，如：家庭會議。
 - (5)利用行為或認知策略，教導病人規律呼吸、放鬆技巧及冥想來減輕恐懼。
 - (6)安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕恐懼，如：可將家中物品帶來醫院。
 - (7)常予探視並表示關懷，減輕恐懼。
 - (8)加強病人本身的宗教信仰及理念或提供相關資訊，協助度過恐懼時期。
 - (9)教導病人當感覺恐懼或心情惡劣時，勿單獨應付，應尋找外來的支持系統，如：找朋友或家人談心。
 - (10)鼓勵病人時常向自己信任的朋友，表達心理的感受，抒發心情減輕恐懼。
 - (11)病情許可鼓勵病人維持正常社交或娛樂活動，分散注意力。
 - (12)注意安全，避免病人獨處並提早發現異常情緒變化，預防意外發生，如：自殺。
 - (13)持續監測病人恐懼程度，如恐懼持續影響正常生活，應予會診精神身心科提供心理諮商。

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/11

- (14) 若恐懼感持續無法改善，必要時依醫囑給予鎮靜藥物治療。
- (15) 鼓勵病人和家屬說出對疾病、功能受損程度、迫近死亡的害怕及關心。
- (16) 評估家屬是否出現調適機轉失常，如：否認病人的診斷或嚴重度、無法忍受病人、排斥病人、放棄病人和敵視病人。
- (17) 提供信賴與關心的氣氛，和家屬共同討論並計畫適當的病人照顧措施。為病人及家屬提供獨處的機會，並允許家屬參與病人的照顧工作。
- (18) 支持並讚賞家屬為病人的照顧所做的努力。鼓勵家屬加入癌症病人家屬支持性團體。
- (19) 評估病人和家屬目前所處哀傷過程階段。提供開放式且支持性環境，盡可能使病人以哭泣、生氣和退化行為發洩情緒，並讓家屬瞭解發洩的重要性。

7.家庭因應能力：成長潛能/與家庭成員罹患嚴重疾病有關

- (1)瞭解並評估病人目前所發生的問題對家庭帶來的影響。
- (2)評估病人家庭解決問題的能力。
- (3)瞭解病人家庭對目前問題所提出的因應方法。
- (4)協助病人家庭確認並應用有意義的健康促進行為。
- (5)找出病人家庭不正確的認知行為或知識並促進瞭解。
- (6)提供或安排病人家庭成員間的互動溝通時間。
- (7)指導病人家庭成員瞭解自己的角色及功能。
- (8)提供病人家庭成長及因應問題所需的資訊。
- (9)促進病人家庭成員間彼此的支持。
- (10) 提供社區及團體的資源，以拓展病人家庭因應問題的能力。
- (11) 鼓勵病人和家屬說出對病人疾病、功能受損程度、迫近死亡的害怕及關心。
- (12) 評估家屬是否出現調適機轉失常，如:否認病人的診斷或嚴重度、無法忍受病人、排斥病人、放棄病人和敵視病人。
- (13) 提供信賴與關心的氣氛，和家屬共同討論並計畫適當的病人照顧措施，為病人及家屬提供獨處的機會，並允許家屬參與病人的照顧工作。

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/11

(14) 支持並讚賞家屬為病人的照顧所做的努力。鼓勵家屬加入癌症病人家屬的支持性團體。

8. 尋求(特定的)健康協助（放射線和化學治療的副作用、居家照顧事項）/與資訊不足有關

(1) 認識放射線及化學治療的副作用

- A. 因放射線及化學治療會引起骨髓受抑制的副作用，故需教導認識感染的徵象，如：發燒、咳嗽、喉嚨痛、解尿灼熱感等，強調勿與已知有感染的個人相處在密閉的環境。
- B. 因骨髓抑制引起血小板數減少，故需教導認識有關出血傾向加劇的徵象和症狀，如：瘀斑、瘀點、牙齦出血、血尿、血便等。
- C. 教導病人使用軟毛牙刷和電動刷牙機、電動刮鬍刀，以免造成組織損傷。
- D. 腸胃道症狀，如腹瀉、噁心、嘔吐，可採少量多餐、止吐劑使用來預防。
- E. 每天攝取 2-3 公升液體，以預防尿酸的沈積。
- F. 鼓勵戴假髮或帽子，以解決因化學治療所引起的禿髮。

(2) 瞭解居家照顧的注意事項

- A. 解除疼痛、厭食、噁心、嘔吐和脹氣症狀的方法。教導服用藥物的注意事項：藥名、劑量、時間、途徑、副作用等。
- B. 教導觀察傷口感染的徵象：發紅、腫脹、疼痛、膿性分泌物、惡臭味等；教導傷口護理和換藥技術。
- C. 教導預防或消除因放射線或化學治療引起的副作用。

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	9/11

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林貴滿(2019)・消化系統疾病病人之護理・於胡月娟總校閱，內外科護理學(六版，758-767)，華杏。
- (二) 吳麗彬、周繡玲(2020)・消化系統疾病之護理・於劉雪娥總校閱，成人內外科護理(八版，381-389 頁，下冊)，華杏。
- (三) 中山醫學大學附設醫院胃癌多專科醫療團隊編修(2023)・胃癌臨床診療指引，中山醫學大學附設醫院。
- (四) 王伊岑、楊雪玲、黃文聰(2022)・一位胃癌末期病人臨終照護經驗・若瑟醫護雜誌，16(1)，43-55。

七、附件

(略)

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.11.30	1.0	新制定。	97 年 11 月 30 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改胃部腫瘤定義。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31.	3.1	更新第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 新增第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 1、第六項第四目參考資料修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.4	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	胃部腫瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
111.11.08	3.5	1. 第三項第四、五、六目內容修正。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.6	1. 第三項第五、六目護理問題及護理措施內容修正。 2. 第六項參考資料修訂。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	3.7	更新第六項參考文獻資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	